



MANUAL DE INDUCCIÓN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

1. INTRODUCCIÓN.

La Dirección del Departamento de Salud y su personal; la Dirección del CESFAM y el Equipo de Salud le dan la más cordial bienvenida y le invitan a formar parte de esta Organización, a comprometerse y alinearse con sus objetivos, esperando que aquí usted encuentre un espacio de desarrollo profesional y laboral y un aporte importante a su crecimiento personal.

El equipo de trabajo está formado por 119 funcionarios, que se distribuyen en las distintas categorías funcionarias (A, B, C, D, E y F) y que se desempeñan tanto en el Departamento de Salud, como en el CESFAM, en el Sector Urbano, Rural o en ambos.

Forman parte del CESFAM 3 Postas de Salud Rural: Posta Población, Posta Los Cardos y Posta Calleuque y 1 Estación Médico Rural en Sector Rinconada de Molineros.

La población a cargo es de 14.289 usuarios validados por el FONASA para el año 2026.

Las prestaciones de salud entregadas corresponden al PLAN FAMILIA SANA definida por el Ministerio de Salud y las acciones anuales están definidas por un Plan de Salud Comunal.

Las actividades que usted deberá realizar, sus responsabilidades y objetivos a cargo serán designadas por su jefe directo respetando siempre el organigrama institucional y que además están definidas en el manual de funciones correspondiente.

Nuestra labor conlleva un desafío hermoso: Promover la salud, prevenir la enfermedad y recuperar el daño cuando se ha producido. Le invitamos a formar parte de un equipo humano que siempre deberá tener presente la acogida y el buen trato a nuestros usuarios y las buenas relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo.

Las funciones que cada miembro del Equipo de Salud lleva a cabo están guiadas por una misión y una visión que está plasmada en nuestro Plan de Salud Comunal y que procuramos, a través de todas nuestras actividades de intervención y de gestión, hacer efectivos.

2. RESEÑA HISTÓRICA DE CESFAM.

Los datos de atención de salud en Peralillo de manera más institucional datan del año 1930 con la fundación del Hospital de Peralillo cuyo primer Director fue el Dr. Orlando Leyton A, de profesión médico y quien ejerció por más de 45 años en la Comuna.

El año 1981 por decisión ministerial el Hospital pasó a ser un Consultorio General Rural.

El año 1987 se realiza el traspaso de los servicios de salud a la administración municipal.

Desde el año 1995 a 2010 comenzó en el país una etapa de transformación en la atención primaria, que culmina con la certificación a Centro de Salud Familiar y recertificación el año 2013, lo cual rige hasta la actualidad.

Los dispositivos de postas datan desde el año 1981 a 1983 sus construcciones.

En la actualidad estamos en etapa de reposición a un nuevo CESFAM que pueda hacer frente a los nuevos desafíos en salud del país.

3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.

MISION: Somos, en el marco de la Atención Primaria de Salud, un Centro de Salud Familiar que trabaja en equipo, con énfasis en la calidad asistencial, situando al usuario, su familia y la comunidad en el centro de nuestro quehacer, mediante acciones integrales de Promoción, Prevención, Diagnóstico, Recuperación y Rehabilitación de la Salud, en estrecha colaboración con el intersector y las redes asistenciales de salud, procurando entregar un servicio humanizado y oportuno, empoderando de manera participativa a la comunidad a fin de hacerla corresponsable de su salud.

VISIÓN: Seremos un Centro de Salud Familiar que brinda atención de calidad, integral, multidisciplinario y centrado en el usuario, su familia y la comunidad, valorado y reconocido a nivel local y de la red de Salud Nacional, que incorpora, de manera activa, a sus usuarios, quienes son protagonistas participativos y corresponsables de su salud.

4. VALORES QUE ENMARCAN EL QUEHACER

Son valores transversales y prioritarios

- Humanización de la Atención
- Ética
- Compromiso e identificación con la Institución
- Trabajo en equipo y compañerismo

Es nuestro compromiso trabajar para que nuestro Departamento de Salud, CESFAM y Postas sean reconocidos por las personas, las familias y la comunidad como un lugar acogedor, donde sientan que de verdad nos interesan sus problemas, requerimientos e inquietudes.

Por lo tanto, la invitación es a integrarse a un equipo de trabajo comprometido y humano, que se esfuerza por dar respuestas efectivas, oportunas y de calidad.

5. NUESTRO MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

ES EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA que se caracteriza por ser de carácter integral, familiar y comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa que las personas sean atendidas en las

etapas tempranas de la enfermedad, de modo de controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos.

Los elementos fundamentales de este enfoque se resumen en lo siguiente:

- ✓ Que esté centrado en el usuario, facilitando el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en salud.
- ✓ Que tenga un énfasis en lo promocional y preventivo; con enfoque familiar de los cuidados.
- ✓ Que sea integral tanto en la comprensión de los fenómenos, como en las formas de afrontarlos.
- ✓ Que garantice la continuidad de la atención, desde los cuidados primarios, hasta las modalidades de atención especializada.
- ✓ Que trabaje en Red tanto sanitaria como social y que asegure la complementariedad que requieren las necesidades explícitas e implícitas en salud.
- ✓ Que tienda al cuidado ambulatorio.
- ✓ Que abra espacios para la participación en salud y la intersectorialidad.

Como una forma de asumir la **integralidad** de las situaciones de salud-enfermedad de las personas y familias, se planteó la necesidad de inducir una mirada sistémica, poniendo el acento en ampliar el enfoque biomédico a un enfoque que fuera capaz de incluir las distintas dimensiones del ser humano que ayudara a comprender la experiencia manifestada en síntomas o signos.

Las barreras entre salud y enfermedad no son tan claras, la salud no es un producto, ni un estado, sino un proceso multidimensional en el cual permanentemente interactúan sistemas biológicos, psicológicos, sociales, culturales, familiares, ambientales. La comprensión diferente de la situación salud enfermedad, necesariamente debe traducirse en la búsqueda de respuestas más integrales, tanto desde el sistema de cuidado familiar como desde el equipo de salud. La posibilidad de abrirse a respuestas innovadoras es mucho mayor.

5.1. PRINCIPIOS DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA (MAISFC)

La familia influye en la salud y en la enfermedad de sus miembros. Así mismo la situación de salud de cada miembro influye al sistema en su conjunto. Esta relación se ha expresado como la existencia en la familia de características que pueden ser factores protectores o de riesgo para determinadas alteraciones en la salud, en determinadas pautas de conducta, en la forma cómo la

familia reacciona frente a la enfermedad, como cuidadora, como conceptualiza la salud o cómo se organiza el funcionamiento familiar frente a la enfermedad.

La **continuidad del cuidado** es una aspiración de las personas y se constituye en uno de los principios relevantes del enfoque centrado en la familia. La atención personalizada y mantenida a lo largo del tiempo, permite un conocimiento acumulativo de las personas y familias a cargo, desarrollo de vínculos y un compromiso profundo entre los integrantes del equipo de salud y su población a cargo. En un sentido global, como Sistema de salud, la continuidad puede ser comprendida, como la respuesta continua que se otorga a las personas en los distintos puntos de la Red de salud, tanto en los cuidados primarios como especializados, ya sea ambulatorio como en la atención cerrada, e independiente del lugar geográfico del país donde la persona se encuentre por razones laborales u otras.

En el análisis de situaciones de salud, el **trabajo en equipo** no jerarquizado es una característica esencial y condición necesaria para el enfoque multidisciplinario. La confluencia de miradas desde diferentes disciplinas aporta a un análisis más integral de la situación de salud, no sólo de individuos y familias, sino de la comunidad en su conjunto.

El equipo de salud se hace parte de las estrategias que la potencian, en miras a una mejor calidad de vida. El equipo necesita introducirse en el contexto social, comunitario y familiar para mejorar la comprensión de las distintas dimensiones en que ocurre la vida de la población a cargo y una mejor utilización de los recursos existentes a nivel familiar, comunitario y social.

La conformación de equipos de salud multidisciplinarios a cargo de poblaciones pequeñas facilita el acercamiento. Se establece una relación equipo-comunidad que enfatiza una mayor responsabilidad por el autocuidado y el cuidado del entorno. La comunidad es parte del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR

- ✓ Enfoque Biopsicosocial, con énfasis en la Familia y Comunidad.
- ✓ Continuidad de la atención y de los cuidados de salud.
- ✓ Prestación de servicios integrados.
- ✓ Resolutividad.
- ✓ Responsabilidad compartida entre todos los miembros de la familia y comunidad.
- ✓ Participación Social.
- ✓ Promoción de Salud.
- ✓ Interculturalidad.
- ✓ Impacto Sanitario.
- ✓ Enfoque de Género

Se espera que todos los funcionarios del Departamento de Salud tengan conocimiento de Salud Familiar, por lo que, si usted no tiene algún curso de formación en Salud Familiar durante el

primer año realice al menos el curso básico. Esto será supervisado por el Encargado del Modelo de Salud Familiar.

6. MATERIAS RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO.

A continuación se señalan las materias relevantes y generales que Ud. debe conocer para desempeñarse en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Peralillo.

- 1.- Objetivos estratégicos de salud a nivel comunal.
- 2.- Objetivos sanitarios estratégicos nacionales.
- 3.- Metas Sanitarias comuna Peralillo.
- 4.- Indicadores de Atención Primaria en Salud Comuna Peralillo.
- 5.- Organización interna.
- 6.- Instancias de participación interna.
- 7.- Nexos con la comunidad.

5.1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMUNALES 2026-2028.

En la reunión de Jefes de Programa del mes de Septiembre de 2025, los presentes concuerdan con Director de CESFAM en dar un nuevo enfoque de estrategia para los próximos 3 años. Esto en relación a fortalecer iniciativas con una mirada en la institucionalidad, considerando el contexto actual a nivel país, enfocando el quehacer en los procesos de mejora y control de los organismos públicos. Es por ello que se avanzará de forma simultánea en 3 objetivos:

- Fortalecer principios institucionales de gestión documental: En miras a eliminar de forma segura documentación obsoleta y promover la digitalización de manera de lograr una ficha clínica unificada y contribuir al cuidado del medio ambiente.
- Implementar sistema de auditorías clínicas institucionales: Considerando la complejidad de las prestaciones en atención primaria, se hace necesario revisar procesos asistenciales con mirada de gestión clínica.
- Fomentar la innovación de gestión institucional: Socializando y colocando en marcha la metodología kai zen a nivel institucional.

5.2. OBJETIVOS SANITARIOS Y ESTRATÉGICOS AÑO 2021 - 2030

1. Mejorar la salud y bienestar de la población.
2. Disminuir las inequidades.
3. Asegurar la calidad de la atención en salud.
4. Avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables.

Para el logro de estos objetivos se plantearon 7 ejes estratégicos, a saber:

EJE 1: Medio ambiente y entornos saludable: Condiciones sanitaria ambientales (agua, aire, residuos, áreas verdes y otros), salud ocupacional, salud familiar y comunitaria

EJE 2: Estilos de Vida: Alimentación saludable, actividad física, consumo de tabaco, alcohol, drogas, salud sexual y reproductiva, salud mental.

EJE 3: Enfermedades transmisibles: Tuberculosis, VIH/SIDA, transmisibles en eliminación, zoonóticas, infecciones respiratorias agudas, resistencia antimicrobiana.

EJE 4: Enfermedades crónicas no transmisibles y violencia: Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, ERC, Obesidad, Enfermedades respiratorias crónicas, trastornos bucodentales, trastornos mentales, violencia.

EJE 5: Funcionamiento y discapacidad: Desarrollo integral infantil, espectro autista, alteraciones músculo esqueléticas, artritis reumatoidea, enfermedades raras o poco frecuentes, accidentes de tránsito, dependencia severa.

EJE 6: Emergencias y desastres: Riesgo de desastres, gestión del riesgo, resiliencia del sector, cambio climático.

EJE 7: Gestión, calidad e innovación: Gestión del personal, infraestructura y equipamiento, tecnología e información en salud, financiamiento del sector, participación social, salud digital, donación y trasplante de órganos y tejidos, seguridad y calidad de la atención.

Tales objetivos integran diversos conceptos y determinantes que insiden en la salud nacional, ampliando el concepto a distintas áreas y haciendo responsable a todos los actores sociales de la misma.

5.3 METAS SANITARIAS NIVEL PAIS LEY N° 19.378.

Son Metas estándar anuales que propone el MINSAL para todo el país y que son negociadas cada año entre el Servicio de Salud O'Higgins y los equipos de salud de la comuna, las que varían anualmente.

AREA A EVALUAR	
1) Recuperación del desarrollo psicomotor	2) Cobertura de Papanicolaou
3) A. Niños de 0-9 años con control odontológico	3) B. Niños/as de 6 años libres de caries
4) A. Cobertura efectiva DM tipo 2 en personas de 15 y más años	4) B. Evaluación anual del pie en personas con diabetes bajo control de 15 y más años
5) Cobertura efectiva HTA en personas de 15 y más años	6) Cobertura de Lactancia Materna Exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida
7) Establecimientos con Plan de Participación Social elaborado y funcionando participativamente	8) Cobertura efectiva de usuarios con asma y EPOC de 5 años de edad en adelante.

5.4 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ATENCIÓN PRIMARIA.

Son Metas estándar anuales que propone el MINSAL para todo el país.

AREA A EVALUAR		
1) Porcentaje de Centros de salud autoevaluados mediante Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario (MAIS) vigente	2) Continuidad de la atención	3) Fármacos trazadores disponibles
4) Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año	5) Porcentaje de consulta médica de resuelta en APS	6) Tasa de visita domiciliaria integral
7) Cobertura examen preventivo en hombres y mujeres de 20 de 64 años	8) Cobertura examen preventivo en adultos de 65 y más años EMPAM	9) Cobertura de evaluación del desarrollo sicomotor de niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control
10) Cobertura de Salud Integral Adolescente de 10 a 19 años	11) Cobertura altas odontológicas totales en población menor de 20 años	12) Cobertura de atención Integral a personas con trastornos mentales 13) Tasa de atenciones en salud mental 14) Porcentaje de altas de programa salud mental
15) Cumplimiento de garantías GES	16) Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso	17) Ingreso a control precoz del embarazo (antes de las 14 semanas)
18) Cobertura de método anticonceptivo en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan métodos de regulación de fecundidad	19) Cobertura DM tipo 2 en personas de 15 y más años	20) Cobertura HTA en personas de 15 y más años
21) Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita.	22) Proporción de niñas y niños menores 2 años con estado nutricional normal	

6. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y EQUIPOS DE SECTOR.

Todos los funcionarios son dependientes del Departamento de Salud Municipal, y por lo tanto con dependencia jerárquica del Sr. Alcalde de la Comuna de Peralillo, y se rigen por la Ley N° 19.378 de la Atención Primaria de Salud.

Si su área de desempeño es el Departamento de Salud propiamente tal, usted pertenece a una de las siguientes áreas:

- Dirección de Departamento de Salud
- Personal
- Finanzas
- Adquisiciones

Actualmente la Jefa de Departamento de Salud es Doña Ángela Araya Valdés.

Debe saber que territorialmente Peralillo está dividido en 2 Sectores:

- a) Sector Urbano: Comprende Peralillo Urbano y sectores a unos 5 km de distancia como lo son Puquillay, Los Leones, Rinconada de Peralillo, La Troya Norte, Centro, Sur, San Isidro entre otros.

El Centro de atención para estas localidades es CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

Actualmente el Director de CESFAM Dr. Orlando Leyton A. es Dr. Cristian Cárdenas Espinoza

Jefa de Sector Urbano: Trabajadora Social Beatriz San Martín Rodríguez

- b) Sector Rural: Corresponde a los territorios donde están emplazadas las postas:
- Posta de Población: Abarca Población, Santa Ana, El Cortijo y depende además de ella la EMR Rinconada de Molineros
 - Posta Los Cardos: Abarca Los Cardos Casa, Los Cardos Peralillo, Santa Blanca.
 - Posta Calleuque: Abarca sector Calleuque, Parrones.

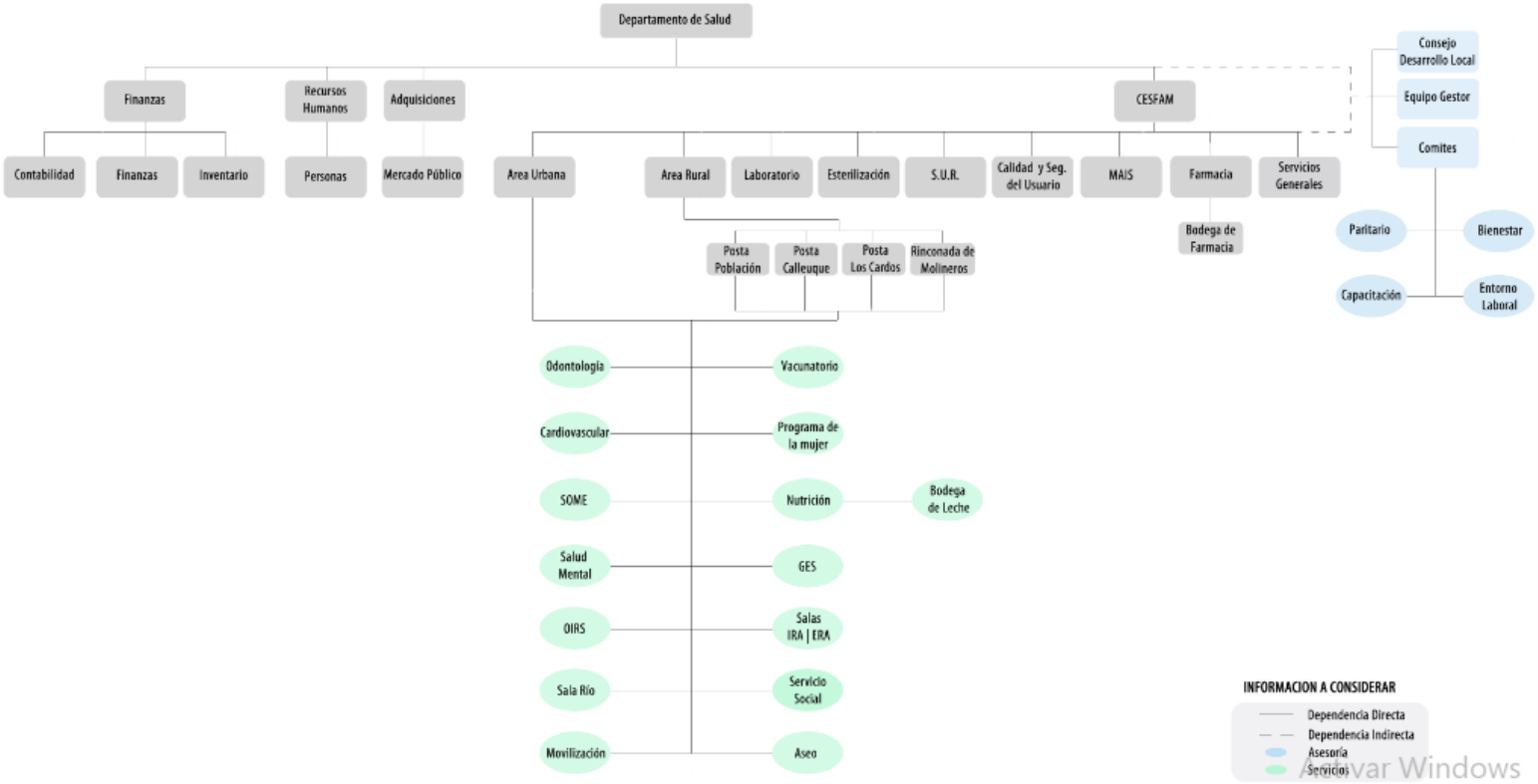
Jefa de Sector Rural: Enfermera Sandy Guajardo Padilla.

Cada Sector está constituido por la Jefa de Sector, profesionales de diversa índole y TENS a cargo de cada Posta (Equipo de cabecera).

Además de ello de manera regional formamos parte de una Red Asistencial cuyo Gestor de Red es el Director del Servicio de Salud y, para efectos clínicos, nuestra vinculación se realiza con los Hospitales de Santa Cruz, San Fernando y Rancagua, principalmente en virtud de la complejidad de los casos que refiramos.

Para efectos administrativos y de gestión de los Programas, nuestros Asesores Técnicos y nuestro Asesor Territorial se encuentran en la Dirección de Servicio de Salud O'Higgins, ubicada en la ciudad de Rancagua. A continuación se presenta organigrama institucional.

6.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



6.2. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN INTERNA.

Respecto a la capacitación de los funcionarios, existe un **Comité de Capacitación** encargado de que la gran mayoría del personal pueda acceder anualmente al menos a una actividad financiada por el CESFAM, complementando las capacitaciones personales que se decidan llevar a cabo año a año, de acuerdo a las necesidades de desempeño detectadas y proyectadas, así como también de dar difusión a los cursos que lleguen como oferta para el Equipo de Salud.

El **Comité Paritario**, favorece una adecuada y oportuna protección y prevención en relación a los riesgos laborales para la salud, el bienestar y la integridad física de los funcionarios y contribuir a mejorar su calidad de vida de todos los funcionarios dentro del trabajo.

La **Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (AFUSAM)**, organización sindical de trabajadores de Atención Primaria en Salud Municipal, pluriestamental, orientada al logro del bienestar económico, político, social y cultural de sus socios, luchando por un sistema público de calidad, centrado en la concepción de la salud como derecho humano fundamental. Dependiente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (CONFUSAM)

El **Comité de Entorno Laboral Saludable**, agrupación conformada por funcionarios que se encarga de generar estrategias para el autocuidado de los funcionarios, organizando actividades que vayan en directo beneficio de su calidad de vida laboral.

El **Comité de Gestión de Reclamos**, Constituido por representantes de la comunidad y del CESFAM, quienes son los encargados de revisar periódicamente las Solicitudes Ciudadanas y generar propuestas de mejora según casos de reclamos, en conjunto con la Dirección del Establecimiento.

El **Comité de Gestión de Interconsultas, listas de espera y contrareferencia**, supervisa, comprueba y asegura la pertinencia, fundamentos y legibilidad de los diagnósticos, exámenes y lugar de derivación con el fin de entregar un buen insumo al profesional del establecimiento de derivación, en beneficio de nuestros usuarios/as.

El **Comité de Bienestar**, propende al mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y sus grupos familiares inscritos como beneficiarios social, económico y humano de los mismos, para lo cual podrá proporcionarles, en la medida que sus recursos permitan, beneficios y prestaciones de salud, atención primaria en policlínico, educación, asistencia social, económica, cultural y recreación, entre otros. Pueden pertenecer todos los funcionarios que estén a contrata o de planta que paguen su cuota mensual, considerando que el valor de esta varía entre asociados y no asociados (Asociación de Funcionarios)

6.3. NEXOS CON LA COMUNIDAD.

El CESFAM cuenta con una organización de usuarios denominada **Consejo de Desarrollo Local de Salud**, la cual está integrada por personas pertenecientes a los distintos sectores de Peralillo. Tiene por objeto asesorar a la Dirección y al Equipo Técnico del establecimiento, siendo un organismo intermediario entre el establecimiento de salud y la comuna, lo que permite recoger sugerencias de la comunidad para el mejoramiento de la salud y entregar información respecto al funcionamiento del CESFAM y sus Postas de Salud Rural.

Programa de Promoción de la Salud, dirige recursos al trabajo promocional; fortalece factores protectores de la salud en la comunidad y colegios principalmente, especialmente considerando factores como alimentación, hábito tabáquico, actividad física y participación social, sexualidad y elementos psicosociales.

Programa Elige Vida Sana, interviene los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles implementando metodologías con un enfoque comunitario e interdisciplinario en diferentes grupos etáreos de usuarios/as.

Programa Más Adultos Mayores Autovalentes: Programa cuyo fin es mantener o mejorar la condición funcional de la población mayor de 60 años y capacitar a la red local en autocuidado y estimulación funcional.

7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS.

7.1.- DERECHOS DE CADA FUNCIONARIO.

1- a) El personal contratado en forma indefinida tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente terminará por lo siguiente:

- Renuncia voluntaria.
- Falta de probidad.
- Obtención de jubilación
- Fallecimiento
- Calificación en lista de eliminación o en su caso, lista condicional, por 2 periodos consecutivos o tres acumulados.
- Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 18.883.
- Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o hallarse condenado por crimen o simple delito,
- Disminución o modificación de la dotación.
- Destitución como resultado de un sumario administrativo.

b) El personal contratado a plazo fijo, su relación laboral terminará por:

- Vencimiento del plazo del contrato.
- Eventos señalados en el punto anterior.

2- Derecho a percibir una Remuneración mensual de acuerdo a la Categoría y Nivel de la Carrera Funcionaria en que esté clasificado, según título II de la Ley 19.378, la que está señalada en el respectivo contrato y en el reglamento interno del CESFAM.

Constituyen remuneración:

a- Sueldo Base: que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por periodo que cada funcionario tendrá derecho a percibir conforme Nivel y Categoría que esté clasificado o asimilado, según título II de la Ley 19.378, la que está señalada en el respectivo contrato.

b- Asignación de Atención Primaria Municipal, que es un incremento del sueldo base a que tiene derecho todo funcionario por el solo hecho de integrar una dotación.

c- Bono Sustitutivo: Es un aporte fijo sin diferenciación por nivel ni categoría. Se paga en proporción a horas trabajadas.

D- Las demás asignaciones, que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en consideración a la naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de salud a desarrollar, a las peculiares características del establecimiento en que se labora y a la evaluación del desempeño funcionario.

Esta son: la asignación por Responsabilidad Directiva (Artículo 27 Ley 19.378), la asignación por desempeño en condiciones difíciles, la asignación de zona, la asignación de mérito, la asignación de desempeño colectivo y la Asignación Transitoria Art. 45 según ley N° 19.378.-.

3- Permisos Administrativos: Permite al funcionario solicitar autorización para ausentarse de sus labores por seis días hábiles en el año calendario, con goce de sus remuneraciones.

Procedimiento de Solicitud:

- Se debe utilizar un formulario disponible en servicios generales del CESFAM, el que debe ser firmado por su jefe directo, acto que indica que se tomarán los resguardos pertinentes para que la ausencia del funcionario solicitante, no cause trastornos en la atención de usuarios y/o en los procesos administrativos.
- Estos permisos pueden fraccionarse por días o medios días, son facultativos del Director del Establecimiento por lo tanto serán concedidos o denegados por este según necesidad del servicio.
- Esta solicitud debe ser realizada con 48 horas de antelación a la fecha de utilización del permiso. Cabe hacer presente que es responsabilidad del funcionario confirmar que su permiso esté autorizado antes de hacer uso de éste.
- Si se requiere hacer uso de un día administrativo por algún imprevisto o emergencia, deberá solicitarlo a su jefatura directa explicando los motivos de ello. Una vez autorizado este deberá ser enviado a la Unidad de Personal.
- Toda ausencia, sin previo aviso será descontado (día no trabajado y/o medio día). No corresponde considerarla como día administrativo.

Permiso Sin Goce de Remuneraciones: Podrá concederse por motivos particulares hasta por tres meses en cada año calendario. Este debe ser aprobado por la máxima autoridad comunal, a través de una solicitud cursada por Oficina de Personal.

Permisos Sindicales: De acuerdo al Artículo 31 de la Ley N° 19.296, los directivos de la Asociación de Funcionarios, tienen derecho hasta 11 horas semanales, para cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo, tiempo que se considerará trabajado para todos los efectos, manteniendo el derecho a remuneración.

4- Feriado Legal: El funcionario con más de un año de servicio tiene derecho a un feriado con goce total de sus remuneraciones. El feriado corresponderá a cada año calendario y será de:

- 15 días hábiles para trabajadores con menos de 15 años de servicio
- 20 días hábiles para trabajadores con 15 años de servicio y menos de 20 años.
- 25 días hábiles para trabajadores que tengan 20 o más años de servicio

El funcionario podrá hacer uso de feriado fraccionado, pero al menos uno de los períodos no podrá ser inferior a diez días.

Procedimiento de Solicitud:

- El feriado debe solicitarse con la debida anticipación (10 días hábiles), a través de un formulario disponible en servicios generales del CESFAM. En este formulario se debe indicar fecha de inicio y término de las vacaciones, debe contar con la firma Jefe Directo y Director del CESFAM, previa coordinación con el equipo al que pertenece.

El personal a Contrata debe tomar su feriado legal dentro del año calendario. No se recomienda que prorrogue sus vacaciones.

Los Jefes Directos deben hacer la programación oportuna de las vacaciones del personal, con el fin de resguardar la atención normal de los usuarios y velar por que éstas sean tomadas dentro del año calendario que corresponda. Recordar que sólo **casos excepcionales y por razones de buen servicio**, feriado legal podrá postergarse para el siguiente año.

El Personal con Contrato indefinido al que se le posterga su feriado por razones de buen servicio, debe gestionar dicho trámite, a lo menos con 25 días hábiles de anticipación al término del año (23 de Noviembre de cada año).

Cabe hacer mención, que las Unidades que cuenten con más de un funcionario, deben programar sus vacaciones de tal forma que no afecten la atención normal del público, manteniendo la continuidad del Servicio.

5- Licencia Médica: es el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada laboral durante un determinado lapso de tiempo, con el fin de atender al restablecimiento de su salud. Durante su vigencia, continuará gozando del total de sus remuneraciones.

La licencia médica se deberá informar a la brevedad posible al Depto. De Salud, para realizar su tramitación ante las Instituciones de Previsión a la cual pertenezca el funcionario. Si esta no se presenta en el plazo legal anteriormente establecido, el funcionario se arriesga a que dicha licencia sea rechazada por la Institución Previsional, con las consecuencias que ello implique.

Cada Funcionario será responsable de verificar que su licencia médica sea autorizada por la Institución Previsional a la cual pertenezca. Si esta es rechazada, el funcionario deberá realizar la apelación pertinente y oportuna ante la entidad a la que está afiliado, apelación que deberá presentar en la Oficina de Personal en un plazo no superior a tres días hábiles desde que fue notificada; de lo contrario será descontada del sueldo en un plazo de 6 meses. El funcionario tiene una última instancia de apelación ante Contraloría, organismo que podría eventualmente realizar un descuento de la deuda o pactar la misma en cuotas.

Además se informa que no se reemplazará al personal, cuando una licencia sea inferior a 5 días, se exceptúan a esta norma, sólo labores de carácter indispensable las cuales evaluará la jefatura.

Por razones de buen servicio, más allá de los plazos legales, para organizar anticipadamente el reemplazo de la tarea o función, ante una ausencia por enfermedad, el funcionario debe dar aviso a su Jefe Directo, con la finalidad de tomar las medidas pertinentes que garanticen la continuidad de la atención de los usuarios y/o de los procesos administrativos involucrados.

Es importante mantener comunicación fluida y oportuna con el Departamento de Salud a través de la Oficina de Personal respecto a eventos y novedades en el contexto de una licencia médica.

6- Atención Médica en Mutua de Seguridad: En materia de accidentes en actos de servicio y enfermedades contraídas en el desempeño de sus funciones.

7- Permutar sus Cargos entre sí. Los funcionarios con contrato indefinido, podrán permutar sus cargos, siempre que se trate de labores de la misma categoría y que las entidades administradoras involucradas den su aprobación.

8- Derecho a Capacitación: Los funcionarios tendrán derecho a participar en capacitación hasta por 5 días en el año con goce de remuneraciones en actividades de formación, capacitación o perfeccionamiento, (Párrafo 6°, Artículo N° 37, Ley 19.378).

Procedimiento de Solicitud.

- Es necesario solicitar autorización a la Dirección del CESFAM, previa coordinación con el Jefe Directo. La capacitación debe ser pertinente al cargo, a las directrices del MINSAL y al Plan de Capacitación Local incorporado al Plan de Salud Comunal vigente.
- El Funcionario deberá presentar Solicitud de Curso junto con Cometido Funcionario donde especifique nombre del curso, fechas, horario y lugar en que se realizará, y obligatoriamente deberá adjuntar el respaldo de la Convocatoria, ya sea correo electrónico, Oficio u otro medio. Los beneficios afectos a Cometidos por motivos de Capacitación son los siguientes:
 1. Por cada tres días consecutivos de Capacitación autorizada, se cancelará 1 viático y su proporcionalidad por el aumento de cada día y 1 pasaje ida y otro de regreso si es en Santiago o pasajes diarios de ida y regreso si es a Santa Cruz, San Fernando o Rancagua.
 2. Menor de tres días o días discontinuos se cancelará colación más pasaje ida y regreso por cada día que el funcionario viaje a Capacitación.
 3. Otros casos puntuales o especiales deberán abordarse directamente con la Dirección del Departamento de Salud a través de la Dirección del CESFAM.

7.2 OBLIGACIONES DE CADA FUNCIONARIO:

- a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua.**
- b)** Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan.
- c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución.**
- d)** Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico.
- e)** Observar estrictamente el principio de probidad administrativa.
- f) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales.**
- g) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.**
- h)** Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos.
- i) Denunciar a la justicia los crímenes o simples delitos y Alcalde los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo.**
- j)** Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o bienes, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- k)** Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente.

l) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico.

m) Conocer las leyes señaladas en el punto VI de este apartado y el reglamento Interno de la Institución.

7.3.- JORNADA DE TRABAJO.

La jornada de trabajo es el período de tiempo durante el cual, el funcionario se encuentra obligado a permanecer en su lugar de trabajo cumpliendo su labor con eficiencia y responsabilidad, asignados al puesto que ocupa.

- La jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder las 44 horas semanales. Se distribuye de lunes a viernes, en horario diurno y continuo, comprendido entre las 08:00 y 20 horas, con media hora de colación, para el personal que almuerza en el CESFAM, PSR, y Departamento de salud y 45 minutos para aquellos que almuerzan fuera de estas dependencias. En este último caso, debe recuperar estos 15 minutos prorrogando su horario de salida. Otras modalidades de horarios serán definidas caso a caso en base a las necesidades del servicio.
- Esta distribución no es aplicable a aquellos funcionarios que participan de un sistema rotativo de turnos cuya jornada ordinaria y normal de trabajo, por la naturaleza de su función, deba cumplirse fuera de los horarios precitados. No obstante, podrá contratarse personal con una jornada parcial de trabajo, de acuerdo con los requerimientos del servicio, en cuyo caso la remuneración será proporcional a las horas contratadas.
- La jornada podrá prolongarse para los funcionarios, que por la naturaleza de su función, se requiera su presencia fuera del horario establecido, debiendo existir una solicitud que lo justifique por parte de Jefe Directo y/o Director del Establecimiento y autorización por parte del Departamento de Salud, previa a la realización de las horas extras (Solicitud de Horas Extras, Documento preestablecido y que se encuentra en poder de Encargado de Servicios Generales de CESFAM).
- La Unidad de Personal, estará encargada de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo adoptada, y será mediante el reloj control, que se hará el seguimiento del ingreso y salida de cada funcionario.
- Los funcionarios deberán registrar la hora de inicio y término de su jornada de trabajo.

Si el funcionario no justifica satisfactoriamente y con las evidencias respectivas, su asistencia al trabajo, se procederá a realizar investigación sumaria, procediendo a las sanciones que se desprendan de ella. Si esta situación es reiterada se procederá de la siguiente manera:

- La primera vez de ocurrencia en el periodo de calificaciones de Septiembre a Agosto se procederá a amonestación escrita.
- La segunda vez de ocurrencia procede anotación de demérito por incumplimiento a las obligaciones funcionarias. Estas anotaciones procederán por cada vez que se cometa la falta.

Situaciones puntuales y excepcionales deberán ser avisadas por conducto regular al Departamento de Salud, Oficina de Personal. El simple olvido, no es en sí, una justificación satisfactoria.

a.- Atrasos.

Se considera atraso todo ingreso posterior al horario establecido.

La sanción por atraso se rige de acuerdo a la siguiente escala:

- 1º atraso; sobre 1 hora al mes, sólo se descuenta.
- 2º atraso; sobre 1 hora al mes, descuento más amonestación.
- 3º atraso; sobre 1 hora y más al mes, descuento y anotación de demérito, (excepción, justificación de cambio de horario o accidente)

b.- Horas Extraordinarias.

Son consideradas horas extraordinarias, aquellas horas de trabajo, que se realizan fuera de la jornada laboral, las cuales deben ser previamente solicitadas, autorizadas y justificadas, por los superiores jerárquicos, para realización de tareas especiales o impostergables para el Servicio. Se deberá utilizar el formato preestablecido para estos efectos.

Aspectos a considerar:

- Bajo ninguna circunstancia, se considerará trabajo extraordinario, el que se realice para corregir atrasos no justificados o subsanar errores del funcionario.
- En ningún caso se autorizarán horas extraordinarias, por el mero propósito de reconocimiento económico adicional.
- No se consideran horas extraordinarias diarias cuando estas sean inferiores a los 20 (veinte) minutos por día. Casos excepcionales deberán ser avalados por jefe directo y Dirección del Establecimiento ante la Dirección del Departamento de Salud.
- Como norma general, 5 días hábiles antes del término de cada mes se tienen que enviar a la Unidad de Personal las solicitudes de horas extras para el mes siguiente.
- Los funcionarios que realicen horas extraordinarias hasta las 20:59 hrs, serán reajustadas con un 25% (horas diurnas) y desde las 21:00 hasta las 07:00 AM del día siguiente, más sábado, domingos y festivos con un 50% de recargo (horas nocturnas).
- Las planillas de horas extras, serán enviadas por la Unidad de Personal al funcionario, dentro de los primeros 05 días hábiles de cada mes para su revisión y aceptación y deberá remitirlas al referente de Personal en el CESFAM en un plazo de 05 días hábiles, en caso contrario estas no serán pagadas en el respectivo mes.
- Las planilla de horas extras deben ser firmadas por el funcionario y su Jefe Directo, en caso contrario no serán canceladas. La firma del jefe Directo garantiza que las horas extras fueron efectivamente realizadas.

c.- Compensación de Tiempo.

Es el tiempo que se compensa por un trabajo extraordinario realizado fuera de la jornada laboral. Algunos aspectos a considerar:

- Las horas extras que son canceladas en tiempo, serán con un recargo de un 25% en caso de las horas diurnas (15 minutos por cada hora) o un 50% si son horas nocturnas (30 minutos por cada hora).
- La solicitud de horas para compensar tiempo, tendrá un mínimo de 1 hora.
- Las Horas Compensadas, deberán ser utilizadas a partir del mes siguiente de su realización, en un periodo inferior a tres meses desde que fueron realizadas.
- Deberá utilizarse formato pre establecido, indicando fecha y horario en que tomará el tiempo a compensar. Es obligación el registro de salida e ingreso en reloj control o libro de asistencia.

d.- Cometido Funcionario

Son ausencias del lugar habitual de trabajo, por reuniones, trámites y/o capacitaciones del ámbito laboral y que deben ser solicitadas y autorizadas mediante formato establecido.

- Las solicitudes de cometido funcionario deberán ser formalizadas al menos con 2 días de anticipación. Se exceptúan viajes programados en último momento, traslados en caso de accidentes o labores de estafeta.
- Según características y naturaleza del evento que originó el cometido, además del pago de pasajes o uso de vehículo según corresponda, se tendrán los siguientes derechos:
 - Derecho al pago de colación por todo tipo de cometido funcionario realizado a las Comunas de Palmilla, Marchigüe y Santa Cruz, cumpliendo con el requisito de salir antes de las 12:00 horas y su regreso posterior a las 15:00 horas. El valor de la Colación tiene un monto determinado por la Unidad de Finanzas de Departamento de Salud, debiendo presentar la boleta correspondiente por dicho valor o mayor a éste y los boletos por pasajes, dentro de la semana siguiente de realizado el cometido.
 - Derecho al pago de Viáticos cuando el Cometido Funcionario es realizado en cualquier otra localidad o comuna diferente a las señaladas en punto anterior. Se cancelará según lo establecido en tabla de Viáticos del Personal afecto a la Ley N° 19.378 del Estatuto de atención Primaria que rige cada año.
- La solicitud de cometido debe especificar el lugar y fecha donde se realizará la reunión o trámite y los motivos de dicho cometido (temas a tratar, objetivos, etc). Adjuntando a la solicitud el documento que cita o convoca; ya sea correo electrónico, Oficio, u otro. (Obligatorio para acceder a este derecho).
- El pago de dichos cometidos; colación, viático y/o pasajes se efectuará a través de un depósito a la cuenta del funcionario. La Unidad de Finanzas, enviará una nómina con los montos de dichas dineros, para que el funcionario firme su recibo. Ante cualquier consulta respecto a estos pagos se debe dirigir directamente a la Unidad de Finanzas.
- Las boletas por dichos cometidos, deben ser enviadas al Departamento como plazo máximo la semana siguiente una vez realizada la actividad y deben venir, con nombre, firma y fecha de la realización de la misma.

- Los funcionarios, que no envíen las boletas de pago de colación y pasajes en el plazo establecido anteriormente, se da por entendido que renuncian a este derecho.
- Los beneficios de Capacitación tienen relación con los cursos de capacitación convocados por el Servicio y financiados por esta misma entidad; no aplica para cursos realizados en forma particular. Es muy importante señalar además que estos beneficios están sujetos a la disponibilidad presupuestaria y financiera del momento

8. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Todos los funcionarios serán calificados anualmente, evaluando el desempeño y las aptitudes de cada uno y tendrán derecho a ser informados de la respectiva resolución (calificación). El funcionario, tendrá derecho a apelar del resultado de su calificación ante el Sr. Alcalde, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de estas. El Alcalde a su vez deberá responder manteniendo o subiendo el puntaje de la calificación en un plazo de 10 días hábiles, desde la fecha de recepción de la apelación.

El sistema de calificación comprende lo siguiente: Una pre calificación realizada por el Jefe Directo y la calificación efectuada por una Comisión. La comisión está integrada por 2 representantes de cada categoría, elegidos en votación secreta por los funcionarios.

Los tramos de puntaje permiten clasificar al funcionario en listas 1, 2, 3 ó 4.

Los funcionarios clasificados en lista 1 y 2 pueden ser considerados para otorgamiento de una asignación de mérito; siempre que se encuentren dentro del 35% mejor evaluado de su categoría. Esta asignación se cancelará en forma diferida de acuerdo a mérito alcanzado, durante los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

- El Tramo Superior, conformado por 11% de los funcionarios mejor evaluados, obtendrán una bonificación de 30% del sueldo base mínimo nacional de la categoría respectiva.
- El Tramo Intermedio, conformado por 11% de los funcionarios que sigan en orden decreciente, obtendrán una bonificación de 20% del sueldo base mínimo nacional de la categoría respectiva.
- El Tramo Inferior, conformado por el 13% restante, obtendrá el 10% del sueldo mínimo.

El funcionario calificado es lista 4 de (eliminación) o por dos años consecutivos en lista 3 (condicional), o tres calificaciones discontinuas en lista 3 a lo largo de su carrera funcionaria, deberá dejar su cargo dentro de 15 días hábiles.

La calificación funcionaria en un proceso que está definido en el Reglamento Interno y evalúa los siguientes factores:

I. FACTOR COMPETENCIA

1.- Calidad, cantidad y eficiencia en el trabajo

1. Atención de usuarios
2. Preparación y conocimientos
3. Responsabilidad
4. Interés, iniciativa y creatividad

II. FACTOR CONDUCTA FUNCIONARIA

1. Asistencia
2. Puntualidad
3. Permanencia
4. Colaboración y compromiso
5. Cumplimiento de normas

III. FACTOR DESEMPEÑO EN EQUIPO DE TRABAJO

1. Relaciones humanas
2. Comunicaciones
3. Capacidad de trabajo en equipo
4. Liderazgo
5. Integración

Nota: El factor de mayor relevancia para derimir en caso de empate en puntajes de calificación funcionaria será el Factor “Desempeño en Equipo de Trabajo” (Párrafo segundo, Artículo 33, Ley 19.378).

9. ACCIDENTES DE TRABAJO Y TRAYECTO

El Centro de Salud Familiar a través de la Ilustre Municipalidad de Peralillo, se encuentra adherido a la Mutual de Seguridad, quién entrega los beneficios de la Ley 16.744, sobre accidentes de trabajo (el que ocurre a causa o con ocasión del trabajo), enfermedad profesional (la causada directamente por el trabajo realizado) y accidente de trayecto (el ocurrido en el trayecto habitual de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo). En caso de ocurrir un accidente, el Comité Paritario del Centro y/o la oficina de Personal es el encargado de derivar y realizar las gestiones para la atención de dichos funcionarios.

En caso de sufrir un accidente laboral usted siempre debe realizar los siguientes pasos, los cuales se encuentran especificados en protocolo de accidentes cortopunzantes de CESFAM:

- Realizar maniobras de primeros auxilios (si el caso lo amerita)
- Informar a su jefe directo
- Presentarse en SUR a fin de constatar lesiones. Se le deberá entregar DAU
- Con el DAU debe solicitar reunión con Director de CESFAM quien llena la hoja DIAT.
- Con esta hoja usted estará en condiciones de ir a Mutual de Seguridad para su evaluación posterior.
- Dirección CESFAM envía vía digital DAU a Comité paritario y Encargada de RRHH de Departamento de Salud para proceder a investigación de caso.

9.1. LEYES QUE RIGEN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

Su conocimiento y cumplimiento constituyen parte de las obligaciones funcionarias:

1. Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.
2. Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (supletoria).
3. Ley 19.653 Probidad Administrativa.
4. Ley 20.285 Acceso a la Información (transparencia)
5. Ley 20.584 Deberes y derechos que tienen las personas en relación con acciones vinculadas en su atención en salud)
6. Ley 19.966 (GES).
7. Ley 19.937 (Acreditación Sanitaria)
8. La Ley Karin (Ley N° 21.643) en Chile es una normativa que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo
9. La Ley Mila (Ley N° 21.372) en Chile garantiza el derecho de niños, niñas, adolescentes (NNA hasta los 19 años) y mujeres gestantes a tener un acompañante (padres, tutores, o personas significativas) durante hospitalizaciones y atenciones médicas, buscando asegurar un trato digno y apoyo emocional, tanto en el sector público como privado, aplicable en preparto, parto, puerperio y hospitalización general, salvo peligro grave para el paciente o acompañante.

OBSERVACIONES: Ante dudas de interpretación o de aplicación de los puntos anteriores, solicitar asesoría y orientación en la Oficina de Personal del Departamento de Salud.

10. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Existen normas, manuales de procedimientos y funciones de cada programa, disponibles en las páginas www.minsal.cl o www.saludohiggins.cl, que es responsabilidad de los funcionarios conocer y cumplir.
2. Los funcionarios deberán usar uniforme y en caso de no tenerlo deberán usar vestimenta formal y acorde a su calidad de funcionario público.
3. Los funcionarios deberán usar placa o tarjeta de identificación personal la cual será entregada por SSG de CESFAM.
4. El sistema de información y comunicación interna, contempla:
 - Documentos administrativos (memorando, órdenes internas, circulares, etc)
 - Publicación en diarios murales
 - Correo electrónico.

5. Se encuentran a su disposición para consulta: Reglamento de Calificaciones, Reglamento Interno, Manual de Funciones, Plan de Salud Comunal, Plan de Capacitación, PLADECO y otros.
6. Usted deberá participar en reuniones convocadas por el jefe directo, jefe de sector, jefe de programa y otras. Son de carácter obligatorio los Consejos Técnicos Ampliados.
7. El presente manual podrá actualizarse y complementarse anualmente, según requerimientos detectados, de acuerdo al Plan de Salud, Metas Sanitarias, Programa de Capacitación y otros de interés para los funcionarios y el Establecimiento.

11.- LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS EN SALUD.

Es importante que usted conozca que nuestro trabajo está también condicionado por la **Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Usuarios en Salud**, los que se traducen en:

a. DERECHOS

- Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud.
- Recibir un trato digno, respetando su privacidad.
- Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad.
- Recibir una atención de salud de calidad y segura según protocolos establecidos.
- Ser informado de los costos de su atención de salud.
- No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso.
- Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención.
- Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria.
- Recibir visitas, compañía y asistencia espiritual.
- Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida.
- A ser incluido en estudios de investigación científica sólo si lo autoriza.
- Donde sea pertinente, se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria.
- Que el personal de salud porte una identificación.
- Inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia.
- Que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización.
- Toda persona mayor de 60 años y/o con discapacidad tendrá derecho a atención preferente.

b. DEBERES

- Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección.
- Conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica.
- Cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto.
- Informarse acerca de los horarios de atención y formas de pago.
- Tratar respetuosamente al personal de salud.
- Informarse acerca de los procedimientos de reclamo.
- Dar prioridad a personas con derecho de atención preferente.

12. OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES.

- Respete los conductos regulares, informando siempre en primera instancia a su jefe directo.
- Procure respaldarse con documentos escritos de toda la información que transmita.
- Realice solicitudes de permisos (feriados, administrativos, días de capacitación) con tiempo, mientras esto sea posible, a través de un documento que podrá conseguir en la oficina de servicios generales.
- Envíe oportunamente toda la información que sea de su responsabilidad.
- Si tiene que salir del CESFAM por causas de trabajo y es una salida anexa a sus Postas (si correspondiere) también debe completar un formulario, donde quede constancia de su salida y el motivo de esta. Si sale dentro de la comuna debe registrarse en carpeta que estará en diario mural de funcionarios, si sale a alguna reunión fuera de la comuna debe pedir un cometido funcionario en la misma oficina.
- Si usted tiene personas o programas a cargo está dentro de sus funciones: Solicitar horas extraordinarias para sus funcionarios, realizar solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios y realizar planificación de gastos. Esto tiene un formato tipo que podrá solicitar en oficina de servicios generales.

13. CARTERA DE PRESTACIONES.

A continuación se presenta la canasta de prestaciones de APS, según decreto vigente al momento de redacción plan de salud comunal 2026, definida esta como “El conjunto de acciones promocionales, preventivas, curativas de mantenimiento y rehabilitación”.

	PRESTACIONES DE SALUD	OBSERVACIONES
I	SALUD DEL NIÑO	
1	Control de salud del niño sano	
2	Evaluación del desarrollo psicomotor	
3	Control de malnutrición	
4	Control de lactancia materna	
5	Educación a grupos de riesgo	
6	Consulta nutricional	
7	Consulta de morbilidad	
8	Control de enfermedades crónicas	
9	Consulta por déficit del desarrollo psicomotor	
10	Consulta kinésica	
11	Consulta y Consjería de salud mental	
12	Vacunación	
13	Programa Nacional de Alimentación Complementaria	
14	Atención a domicilio	
15	Actividades Comunitarias en Salud Mental con profesores de establecimientos educacionales	
16	Examen de salud odontológico	
17	Educación grupal odontológica	
18	Consulta odontológica preventiva (incluye barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario y sellantes).	
19	Consulta tratamiento odontológico (Incluye obturaciones, pulpotomías)	
20	Consulta urgencia odontológica (incluye exodoncia).	
21	Radiografías odontológicas	El establecimiento no cuenta con equipos de Rx
II	SALUD DEL ADOLESCENTE	
1	Control de salud	
2	Consulta de morbilidad	
3	Control crónico	
4	Control prenatal	
5	Control de puerperio	
6	Control de regulación de fecundidad	
7	Consejería en salud sexual y reproductiva	
8	Control ginecológico preventivo	
9	Educación grupal	
10	Consulta morbilidad obstétrica	
11	Consulta morbilidad ginecológica	
12	Intervención Psicosocial	

13	Consulta Kinésica	
14	Consulta nutricional	
15	Consulta y/o consejería en salud mental	
16	Programa Nacional de Alimentación Complementaria	
17	Atención a domicilio	
18	Actividades Comunitarias en Salud Mental con profesores de establecimientos educacionales	
19	Examen de salud odontológico	
20	Educación grupal odontológica	
21	Consulta odontológica preventiva (incluye barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario y sellantes).	
22	Consulta tratamiento odontológico (Incluye obturaciones, destartrajes)	
23	Consulta urgencia odontológica (incluye exodoncia, endodoncia en primera fase).	
24	Radiografías odontológicas	El establecimiento no cuenta con equipos de Rx
III	SALUD DE LA MUJER	
1	Control prenatal	
2	Control preconcepcional	
3	Control de puerperio	
4	Control de regulación de fecundidad	
5	Consejería en salud sexual y reproductiva	
6	Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años	
7	Educación grupal	
8	Consulta morbilidad obstétrica	
9	Consulta morbilidad ginecológica	
10	Consulta nutricional	
11	Programa Nacional de Alimentación Complementaria	
12	Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre	
13	Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar	
14	Examen de salud odontológico en gestantes	
15	Educación grupal odontológica en gestantes	
16	Consulta odontológica preventiva en gestantes (incluye barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario y sellantes).	
17	Consulta tratamiento odontológico en gestantes (Incluye obturaciones, destartrajes)	
18	Consulta urgencia odontológica (incluye exodoncia, endodoncia en primera fase).	
19	Radiografías odontológicas	El establecimiento no cuenta con equipos de Rx
IV	SALUD DEL ADULTOS Y ADULTAS	
1	Consulta de morbilidad	
2	Consulta y control de enfermedades crónicas (incluidas aquellas enfermedades respiratorias de adultos de 20 años y más)	

3	Consulta nutricional	
4	Control de salud	
5	Intervención psicosocial	
6	Consulta y/o consejería en salud mental	
7	Educación grupal	
8	Atención a domicilio	
9	Atención podología a pacientes DM	
10	Curación de Pie diabético	
11	Intervención grupal de Actividad Física	
12	Consulta Kinésica	
13	Consulta odontológica preventiva (incluye barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario y sellantes).	
14	Consulta morbilidad odontológica (Incluye examen de salud odontológico, obturaciones, destartraje y pulido coronario)	
15	Consulta urgencia odontológica (incluye exodoncia, endodoncia en primera fase).	
16	Radiografías odontológicas	El establecimiento no cuenta con equipos de Rx
17	Control por sospecha de virus Hepatitis C	
V	SALUD DE ADULTOS Y ADULTAS MAYORES	
1	Consulta de morbilidad	
2	Consulta y control de enfermedades crónicas (incluidas aquellas enfermedades respiratorias de 65 años y más)	
3	Consulta nutricional	
4	Control de salud	
5	Intervención psicosocial	
6	Consulta de salud mental	
7	Educación grupal	
8	Consulta kinésica	
9	Vacunación anti influenza	
10	Atención a domicilio	
11	Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor	
12	Atención podología a pacientes con DM	
13	Curación de Pie diabético	
14	Consulta odontológica preventiva (incluye barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario y sellantes).	
15	Consulta morbilidad odontológica (Incluye examen de salud odontológico, obturaciones, destartraje y pulido coronario)	
16	Consulta urgencia odontológica (incluye exodoncia, endodoncia en primera fase).	
17	Radiografías odontológicas	El establecimiento no cuenta con equipos de Rx
18	Control por sospecha de virus Hepatitis C	
VI	ACTIVIDADES CON GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS	

1	Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescentes, adulto y adulto mayor.	
2	Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor, considerando tratamiento farmacológico	
3	Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del programa odontológico	
4	Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos de programa del niño y adolescente	
5	Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores 5 años: consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño	
6	Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa de adulto mayor	
7	Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y tratamiento farmacológico	
8	Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de morbilidad, controles de crónicos; espirometrías, atención kinésica en personas de 40 y más años	
9	Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años: consultas de morbilidad, controles de crónicos en programas del niño y adolescente: atención kinésica en programa del niño y del adolescente	
10	Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y más años: consultas de morbilidad, controles de crónicos, espirometría y atención kinésica en programas del adulto y adulto mayor	
11	Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor	
12	Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada	
13	Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria	
14	Acceso a tratamiento de Hipotiroidismo en personas de	

	15 años y más	
15	Tratamiento de erradicación de helicobacter pylori	
16	Acceso a tratamiento salud oral integral de la embarazada	
17	Diagnóstico y tratamiento de Alzheimer y otras demencias: consultas de salud mental, visita domiciliaria, considerando exámenes para el diagnóstico y tratamiento farmacológico para personas de 30 años y más, en programas de adulto y adulto mayor.	
VII	ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS	
1	Educación grupal ambiental	
2	Consejería familiar	
3	Visita domiciliaria integral	
4	Consulta social	
5	Tratamiento y curaciones	
6	Extensión horaria	
7	Intervención familiar psicosocial	
8	Diagnóstico y control de la TBC	
9	Visita domiciliaria de seguimiento	
	Exámenes de Laboratorio Básico:	
	<u>Hematología:</u> - Hematocrito - Hemograma - Recuento de Leucocitos - Recuento de Plaquetas - Tiempo de Protrombina - Velocidad de sedimentación <u>Bioquímica:</u> a) Sangre: - Ácido Úrico - Bilirrubina total y conjugada - Perfil lipídico (incluye colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) - Electrolitos plasmáticos (Sodio, Potasio, Cloro) c/u - Creatinina - Depuración de creatinina - Fosfatasas alcalinas - Glucosa - Glucosa post-carga - Hemoglobina glicosilada - Proteínas totales - Transaminasas oxaloacética / piruvica (GOT/AST Y GPT/ALH) - TSH – T4 libre – T4 - Úrea - Determinación de niveles plasmáticos de drogas	

	y/o medicamentos b) Orina: - Creatinuria - Detección de embarazo - Orina completa / sedimento urinario / albumina - Microalbuminuria cuantitativa c) Deposiciones: - Leucocitos fecales - Sangre en deposiciones <u>Inmunología:</u> - Factor reumatoideo <u>Microbiología:</u> a) Bacteriología: - Antibiograma corriente - Baciloscopia Ziehl Nielsen (toma de muestra) - Examen directo al fresco - Gonococo, muestra, siembra, derivación - RPR o derivar para VDRL - Urocultivo, recuento de colonias, antibiograma b) Parasitología: - Coproparasitológico seriado - Examen directo al fresco c/s tinción - Examen de Graham - Examen gusanos, macroscópico - Tricomona vaginalis (examen directo) - Virus hepatitis C, Anticuerpos de (Anti HCV)	
VIII	EXÁMENES ESPECÍFICOS PARA ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (NO CONSIDERADAS EN CUADRO ANTERIOR)	
	-Perfil bioquímico (Determinación automatizada de 12 parámetros). -Perfil hepático (Incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT). -VDRL. -HIV. -Perfil bioquímico (Determinación automatizada de 12 parámetros). --Perfil hepático (Incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT). -Vitamina B12 por inmunoensayo -Electrocardiograma.	

A las anteriormente enumeradas, se suman las prestaciones incorporadas en los diferentes Programas de reforzamiento y aumento de Resolutividad de la APS. Estas serán identificadas de acuerdo a los programas, adicionales al Plan de Salud y las actividades definidas en el Plan de

Promoción de Salud que son lideradas por el Equipo de Salud, más las actividades de salud que realizan diferentes organizaciones comunitarias del sector y que pueden ser consideradas complementarias para el logro de una meta sanitaria.

La anterior cartera de servicios no establece la cantidad en que la prestación debe darse, ya que, está adecuada a las normas técnicas, a nuestra realidad local y basada en el diagnóstico participativo de problemas. Se programarán considerando la mirada del equipo y la mirada comunitaria.

14. TEMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD DE LOS PACIENTES.

Al momento de hacer ingreso una persona como parte del equipo de trabajo de CESFAM Dr. Orlando Leyton A, tanto en calidad permanente como transitoria, es necesario que adquiera conocimientos generales y específicos acerca del funcionamiento y normas locales del establecimiento. Del mismo modo resulta relevante para nuestra institución el ir incorporando a medida que pase el tiempo la estandarización de procesos clínicos y administrativos que den cuenta de una atención basada en calidad, la cual tiene como objetivo brindar seguridad en la atención para nuestros usuarios y para nosotros mismos en la quehacer profesional diario.

Es por ello que CESFAM ha incorporado una política de calidad basada en la mejora de procesos, donde resulta relevante que usted pueda leer con detenimiento y manejar los siguientes documentos, incorporados en nuestra biblioteca virtual la cual usted tendrá acceso por plataforma google drive:

- ✓ Manejo REAS
- ✓ Código Azul
- ✓ Protocolo RCP
- ✓ Manual IAAS
- ✓ Plan de emergencia
- ✓ Eventos adversos
- ✓ Procedimiento para manejo de accidentes cortopunzantes
- ✓ Registros
- ✓ Procedimientos de enfermería: Administración de medicamentos EV, curaciones complejas, inmunización y manejo de cadena frío, instalación catéter urinario, instalación VVP, guía administración de medicamentos vía IM.



15. RECEPCIÓN DE PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

Nombre : _____
 Cargo : _____
 Fecha de Ingreso : _____
 Mail : _____
 RUN : _____
 Fono : _____

Actividad	Ejecuta		Observaciones
	SI	NO	
INDUCCIÓN DESDE DIRECCIÓN CESFAM			
Presentación oral al nuevo funcionario de los contenidos del Manual de Inducción.			
Entrega Manual de Inducción, descriptor de cargo (según corresponda) en formato digital			
Entrega de OT metas sanitarias e IAAPS, Calendario de reuniones y su participación.			
Entrevista final a fin de aclarar dudas respecto a manual de inducción.			
Explicación de la forma en que será medido su desempeño: Proceso de Calificación funcionaria.			
Se realiza acceso vía google drive a biblioteca virtual de Calidad indicando lectura de protocolos de seguridad del usuario: Manejo REAS, Código Azul, Protocolo RCP, Manual IAAS, Plan de			

emergencia, Eventos adversos, Procedimiento para manejo de accidentes cortopunzantes, Registros.			
SOCIALIZAR: JEFES DE SECTOR RURAL/URBANO			
Presentación a sus compañeros de trabajo.			
REGISTROS: UNIDAD DE RRHH DEPARTAMENTO DE SALUD			
Registro en sistema de reloj control e indicación de horarios de ingreso y salida.			

Observaciones:_____

Firma del Director

Firma del Funcionario

- Original Director.
- Copia al Funcionario.